

Trening *świadomości*

30–70% dłubania zachodzi automatycznie — bez świadomego zauważenia. Bez świadomości nie ma zmiany. Pięć etapów rozpoznawania sygnałów. Klucz całej terapii.

CZAS: 2–3 tygodnie · dziennik codzienny Na początku · przed wprowadzeniem reakcji

ŹRÓDŁO: Azrin & Nunn (1973); Walther i in. (2009); Mansueto i in. (1997, ComB)

JAK UŻYWAĆ

Zrozum, **czym jest dłubanie automatyczne** a czym świadome (sekcja 1), poznaj **pięć etapów łańcucha behawioralnego** (sekcja 2). W sekcji 3 wypełnij **dziennik 5-kolumnowy** dla jednego dnia. Sekcja 4 — plan tygodniowego monitoringu.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Walther i in. (2009): osoby z dermatillomanią dłubią **30-70% czasu bez świadomego zauważenia** — w trakcie oglądania TV, czytania, prowadzenia samochodu, pracy przy biurku. Dopiero *po* kilku minutach lub po widoku krwi/uszkodzenia zdają sobie sprawę, że dłubały. Azrin & Nunn (1973) byli kategoryczni: **bez świadomości nie ma HRT**. Pacjent nie może *przerwać* czegoś, czego nie zauważa. Dlatego pierwsze 2–3 tygodnie HRT to *wyłącznie* trening świadomości — bez prób zatrzymania, bez reakcji konkurencyjnej. Cel: nauczyć mózg **zauważać sygnały ostrzegawcze** w łańcuchu behawioralnym, który prowadzi do dłubania. Najczęstszy błąd terapeutyczny: wprowadzanie reakcji konkurencyjnej zbyt wcześnie. Pacjent się frustruje, bo reaguje za późno, i porzuca technikę. Świadomość jest „nudna”, ale to **jedyny fundament**, na którym reszta HRT działa.

01 Dwa tryby dłubania

AUTOMATYCZNE · 30–70%

Bez świadomego zauważenia. W tle innej czynności (TV, czytanie, praca). Zauważasz *po*: „znowu zaczęłam”. Ten tryb potrzebuje treningu świadomości.

ŚWIADOME · 30–70%

Z intencją „jeszcze tylko to jedno”, „muszę to wycisnąć”. Często przed lustrem. Ten tryb potrzebuje pracy poznawczej i kontroli bodźców.

Proporcje są indywidualne. Niektórzy dłubią głównie automatycznie (np. siedząc przy biurku), inni głównie świadomie (np. przed lustrem). Większość ma obie formy w różnych proporcjach. Dziennik pomoże zidentyfikować *Twoje* proporcje — to wpłynie na wybór technik.

02 Łańcuch behawioralny — pięć etapów

Dłubanie nie pojawia się „znikąd”. To **łańcuch** kolejnych elementów. Im wcześniejszy etap zauważysz, tym łatwiej przerwać.

- 1. Wyzwalacz odległy** — stres, nuda, zmęczenie, konflikt → **2. Wyzwalacz bliski** — sytuacja (lustro, łazienka, kanapa, samochód) → **3. Sygnał wewnętrzny** — myśl („poprawię”), czucie (swędzenie, napięcie) → **4. Pierwszy ruch** — ręka idzie do twarzy/ramienia, palec dotyka skóry → **5. Dłubanie** — ściskanie, drapanie, wydłubywanie.

Cel treningu: przesunąć moment zauważenia z etapu 5 (po fakcie) do etapu 4 lub wcześniejszych. Im wcześniej, tym *więcej miejsca* na decyzję świadomą. Etap 1–2 to *kontrola bodźców* (środowisko).

03 Dziennik 5-kolumnowy — przykład jednego dnia

Każdy epizod dłubania (lub *blisko-epizod*) zapisz w pięciu kolumnach. To **kluczowe ćwiczenie** pierwszych 2–3 tygodni HRT. Po 7 dniach wzorce stają się widoczne.

PORA	MIEJSCE / KONTEKST	WYZWALACZ / SYGNAŁ	CZAS TRWANIA	TRYB / CO PO

Tryb: A = automatyczne (zauważyłem po), Ś = świadome (z intencją). Co po: ulga, wstyd, oba, coś innego.

04 Mój plan monitoringu — tydzień

JAK BĘDĘ PAMIĘTAĆ O DZIENNIKU

— alarm w telefonie, kartka przy łóżku, aplikacja

CO ZAUWAŻAM PO 1–2 DNIACH

— pierwsze wzorce, niespodzianki

Klucz: trening świadomości (*awareness training*) jest *najnudniejszą* i **najważniejszą** częścią HRT. Pacjenci często porzucają go po 3–4 dniach, bo „*nic się nie zmienia*” — co więcej, niektórzy zauważają, że *dłubią więcej*, niż myśleli. To **jest** postęp — to znaczy, że świadomość rośnie. Twohig i in. integrowali uważność w HRT i wykazali, że trening uważności *przed* wprowadzeniem reakcji konkurencyjnej znacząco poprawia długoterminową skuteczność. **Praktyczna wskazówka:** przez pierwsze 7 dni *nie próbuj* nic zmieniać. Tylko obserwuj i zapisuj. To trudniejsze niż się wydaje — większość ludzi chce „*od razu coś zrobić*”. Ale obserwacja *jest* robieniem. Bez tej fazy reszta techniki nie zadziała.